STRESS
ET PRINCIPE DE PSYCHOSOMATIQUE

Pr. DJELLALI

Faculté de Médecine de Bejaia

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION GENERALE

II. ETUDE DE STRESS

II.1. Les caractéristiques de stress

II.2. Les réponses face au stress

II.3. La description du SGA

II.4. Les marqueurs cliniques

II.5. Les marqueurs biologiques

III. TROUBLES DE LA REPONSE DE L'ADAPTATION DE L'ORGANISME AU STRESS

IV. STRESS ET MALADIES PSYCHOSOMATIQUES

I. INTRODUCTION GENERALE

Stress, c'est quoi?

- Le terme, populaire, de stress est un mot anglais, sans équivalent en français, très utilisé de nos jours dans la vie courante.

- Venant du latin **stringere**, serrer, qui évoque une situation de pression et de contrainte.

- Pour le monde médical, il recouvre l'ensemble des réponses de l'organisme soumis à des pressions fortes ou soutenues.

- C'est une réaction réflexe **physiologique** et **psychologique** de l'organisme devant une situation difficile qui demande adaptation ou fuite.

«Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie. Et, par conséquent, vivre c'est s'adapter. »

Alvin Toffler (Le Choc du futur)



Walter B. Cannon
(1871-1945)

La notion d'homéostasie

Walter Cannon est le premier a avoir initié les mécanismes d'action du stress et parlé de la notion d'homéostasie, cette **capacité à pouvoir maintenir l'équilibre interne indépendamment des changements qui affectent l'organisme**



Hans Selye 1907- 1982

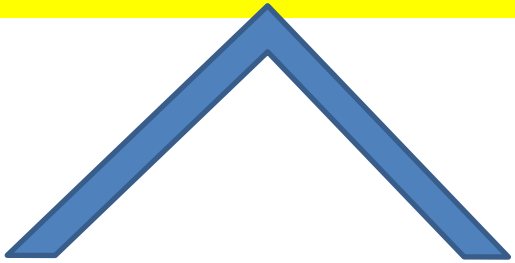
« syndrome général d'adaptation » SGA

Quant à Hans Selye, définit le stress comme **réaction non spécifique de l'organisme qui vise à rétablir l'homéostasie** et l'équilibre de l'organisme,

II. ETUDE DU STRESS

II.1. LES FACTEURS DE STRESS (1)

L'origine des facteurs de stress



les stress cognitifs

Dus à des traumatismes psychiques : émotions violentes, effroi, chagrins intenses à l'occasion des événements dramatiques de la vie

les stress non cognitifs

traumatismes et blessures physiques, infections, douleurs intenses, bruits soudains ou prolongés, chaleur ou froid excessif

Ces deux types de stress, physique et psychique, sont souvent associés.

II.1. CARACTERISTIQUES DE STRESS (2)

Nature des facteurs de stress

- **Stress somatique (agents physiques, chimique et biologique)**
- **Stress psychosocial**

Durée de stress

- **Stress aigu/ chronique**

Conséquences sur le corps

Eu-stress: bon stress
Dé-stress (mauvais stress)

II.2. Réponses face au stress

Même évènement stressant

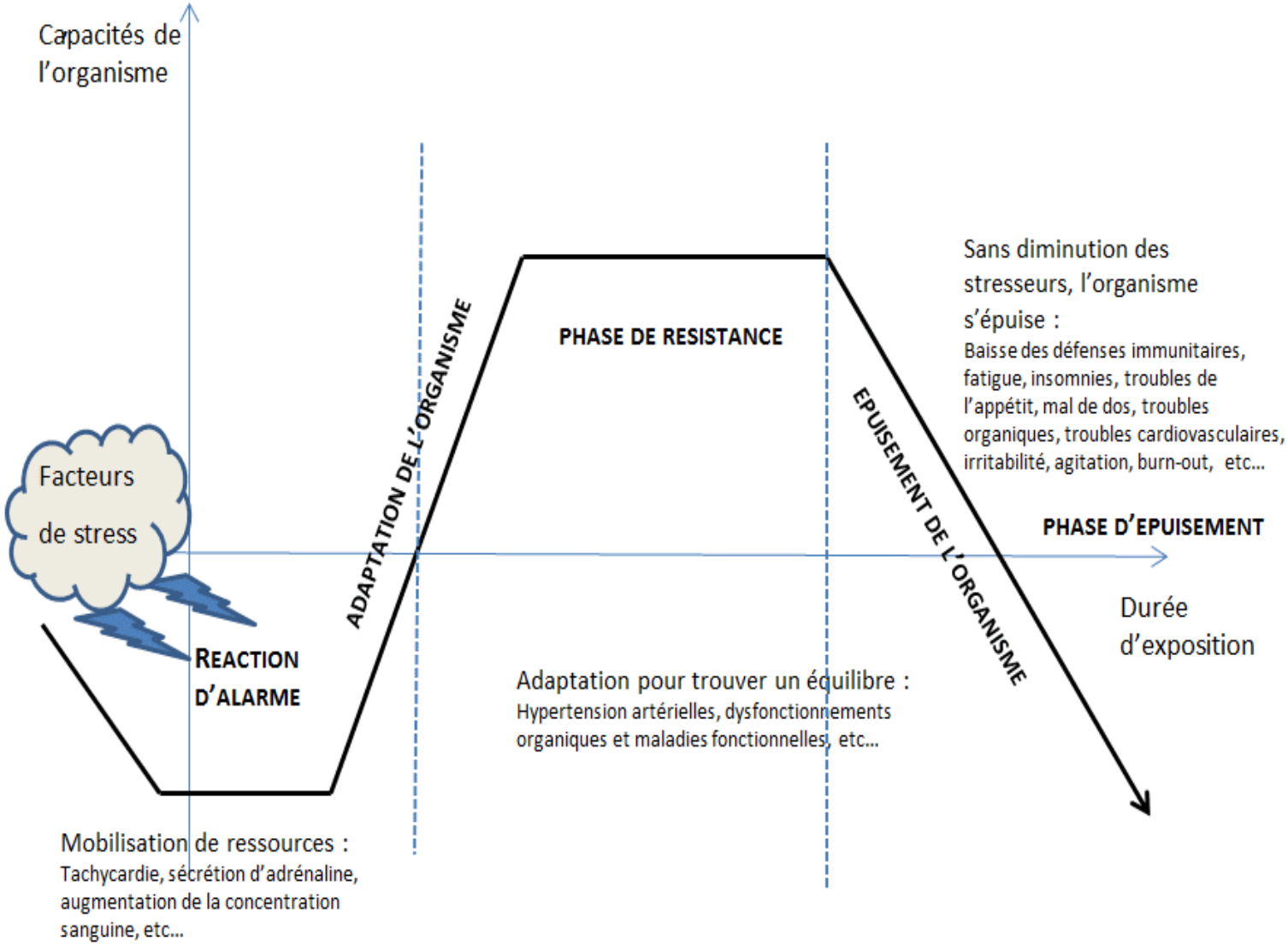
Réponse différente / individu

Car, il tient compte

Caractéristiques individuelles

- de la durée, de la répétition et de l'intensité du stress ;
- des processus cognitifs (attention, mémoire, évaluation)
- de l'âge, de l'expérience de la personne,
- de facteurs génétiques et comportementaux liés à personnalité* de l'individu,
- de l'environnement psychosocial,
- des possibilités individuelles d'adaptation.

II.3. description du SGD



II.3. description du SGD (2)

Stratégies d'ajustement à la maladie

Evènement stressant (maladie chronique)

Stratégies d'ajustement =

« Coping »

Désigne un ensemble d'efforts cognitifs et comportementaux

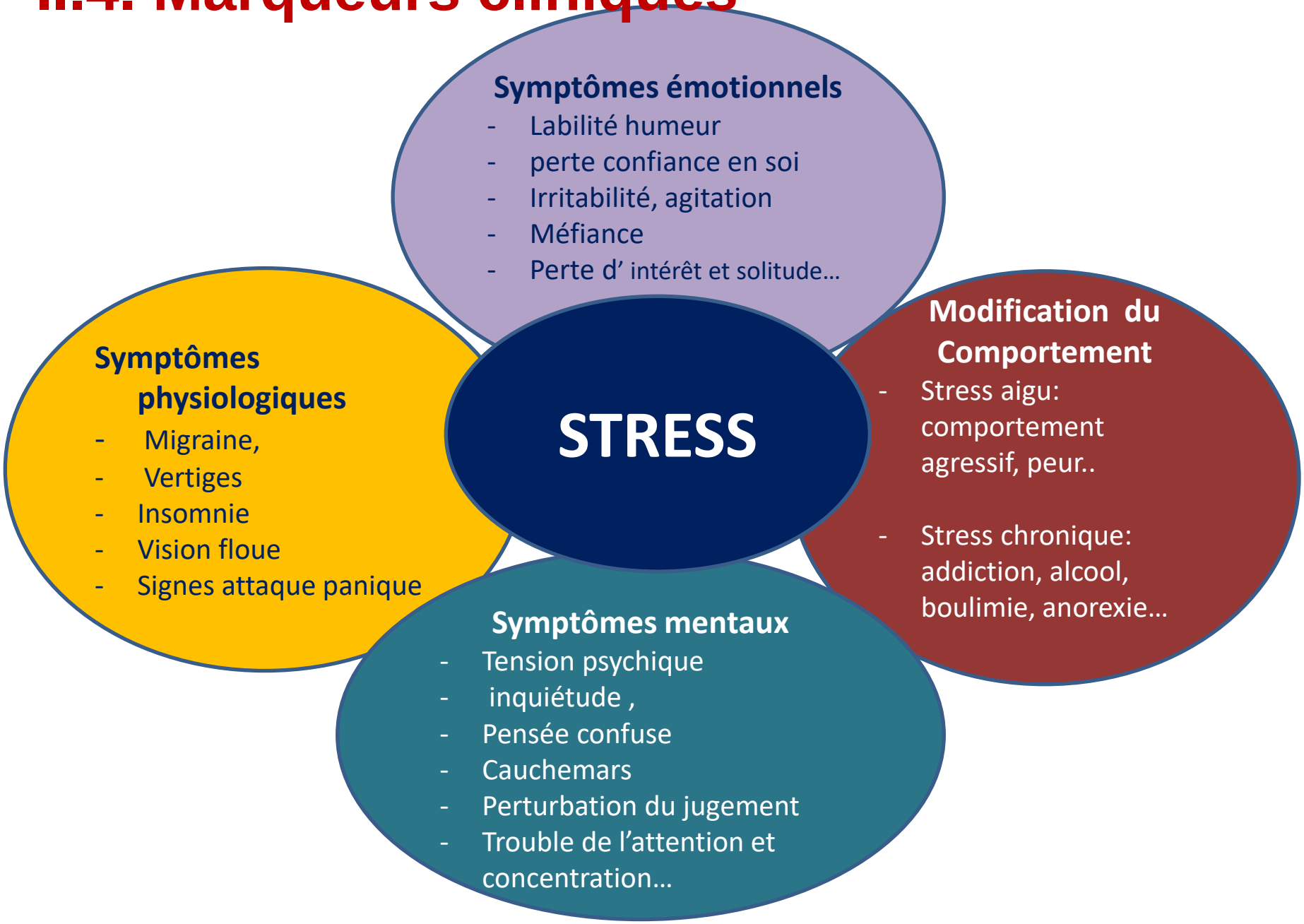
Maitriser , renduire ou tolérer

Bonne adaptation=Bon fonctionnement +

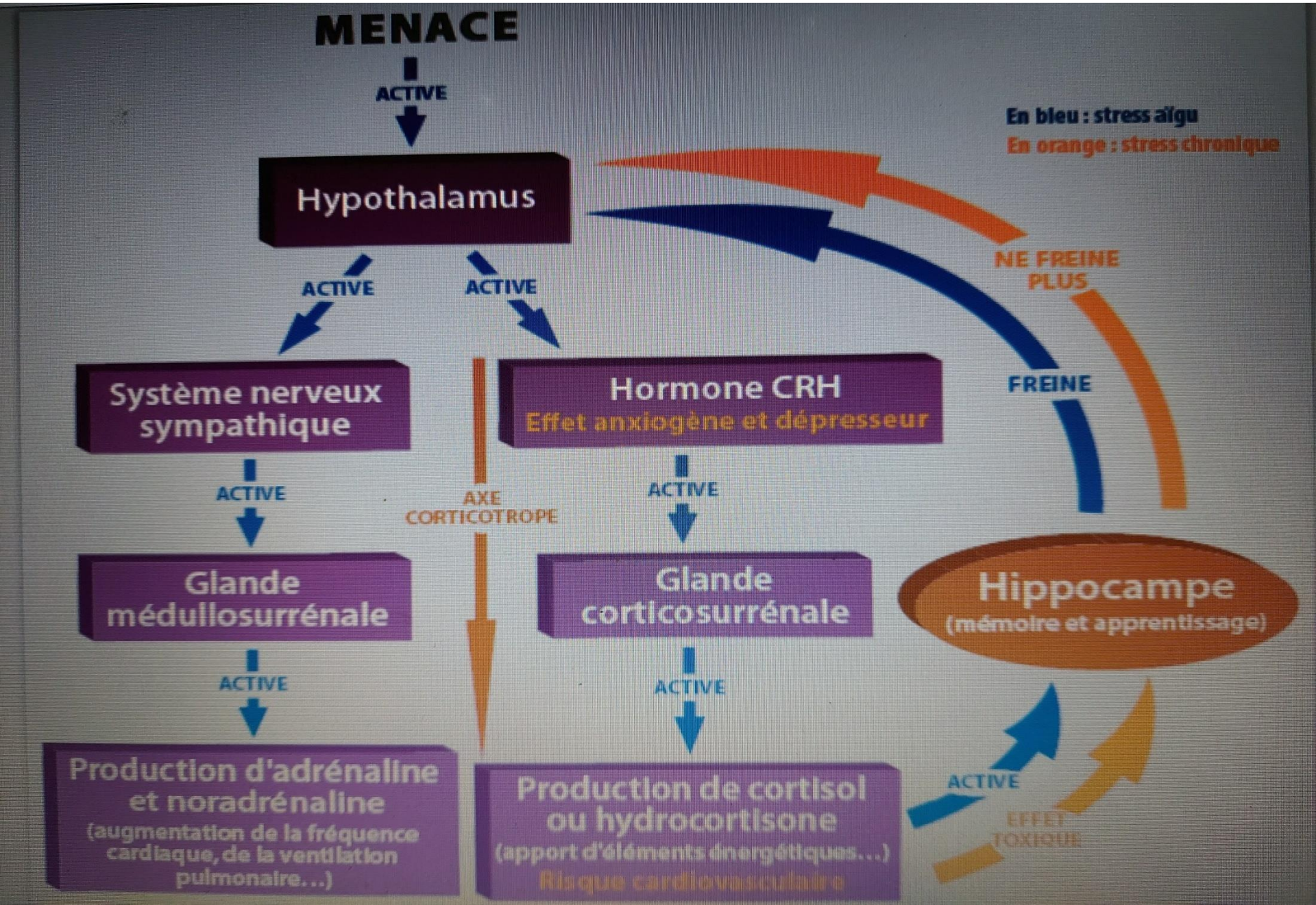
Ressources dépassées

Mauvaise adaptation= altération du fonctionnement global ou souffrance psychique -

II.4. Marqueurs cliniques



III.5. Marqueurs biologiques



III. TROUBLES DE LA REPONSE DE L'ADAPTATION DE L'ORGANISME AU STRESS

1. Les effets du stress aigu

Sujet sain = eu-stress
Sujet avec maladie chronique = Déstresse = déclenchement évènement aigu

2. Les effets du stress chronique

Syndrome de désadaptation:
Maladie psychosomatique, troubles anxieux, abus de substances, anorexie, boulimie..

3. PTSD

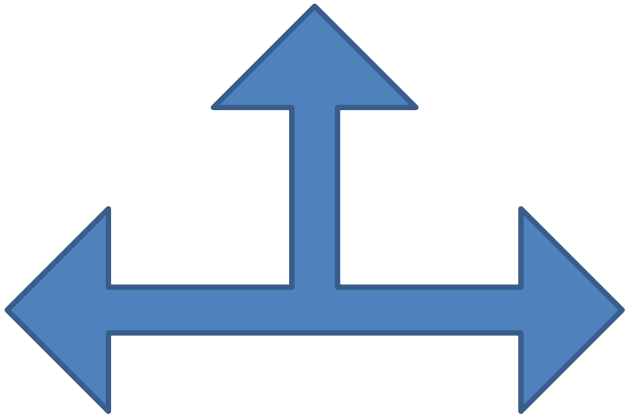
A. Exposition à un évènement traumatique
B. Syndrome de répétition
C. Evitement, émoussement de la réactivité générale
D. Activation neurovégétative
E. Perturbation > 1mois
F. Souffrance avec altération fonctionnement social

IV. STRESS ET MALADIES PSYCHOSOMATIQUES

Le stress : carrefour de la psychosomatique

1/3 **des symptômes somatiques en médecine générale**

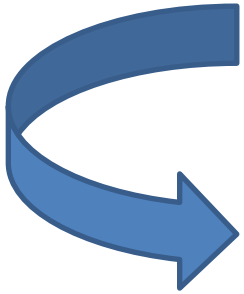
Médicalement inexpliqués



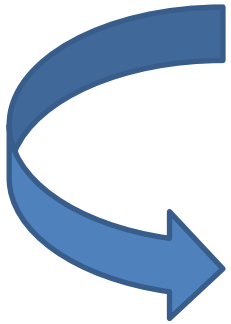
75% disparition ou amélioration après consultation

25% sont chroniques

Le psychosomatique



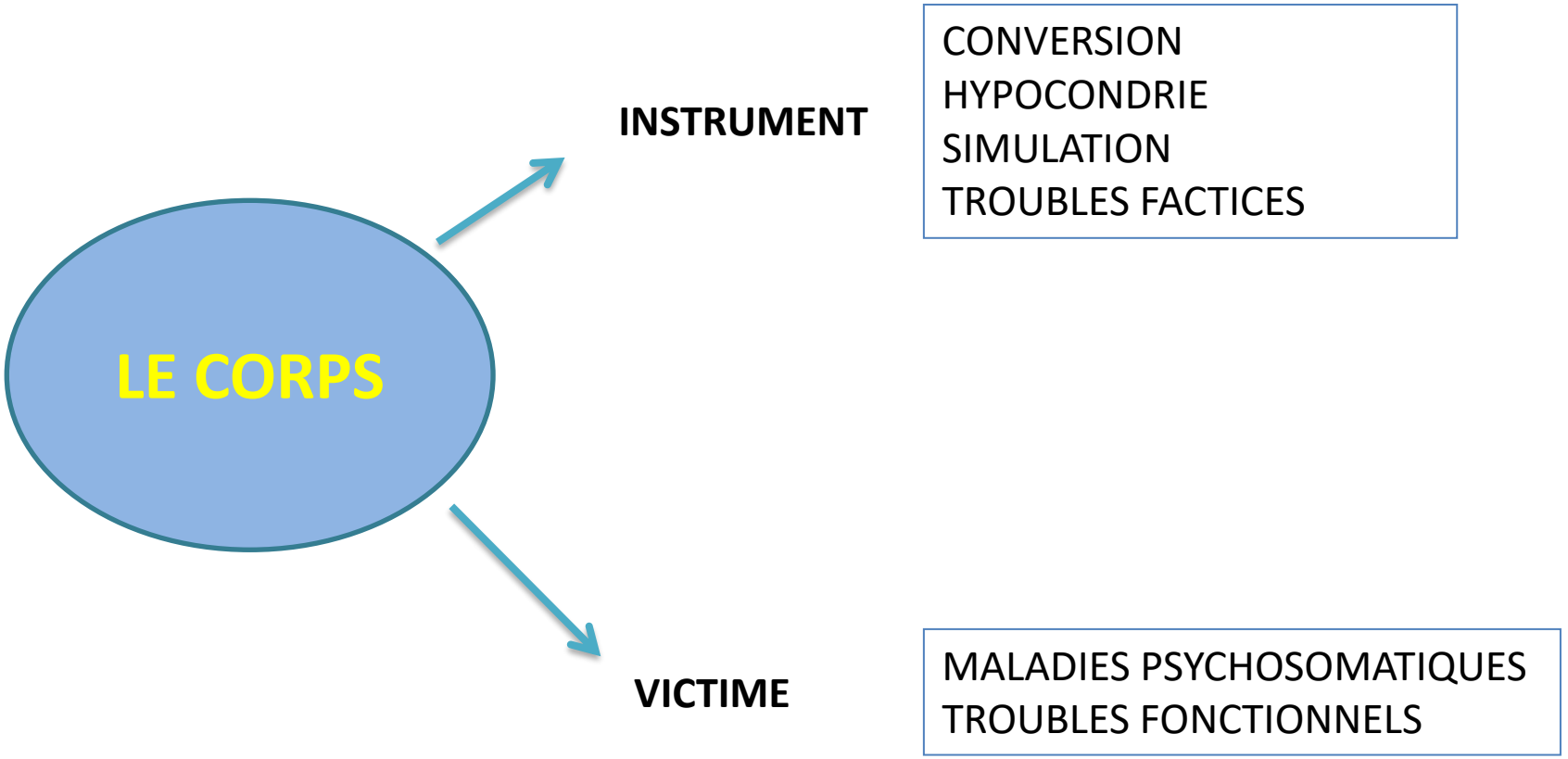
Employé à tort ++++



Symptômes dont l'organicité n'a pas été prouvé

Trouble somatique dont la dimension psychologique est prépondérante dans sa survenue et dans son évolution

Définitions « psychosomatique »



Affections organiques, lésionnelles, dont le déclenchement, l'aggravation ou la récidive sont liés, entre autres, au fonctionnement psychique de l'individu.

III. MANIFESTATIONS PSYCHOSOMATIQUES

Conséquences du stress

Le cerveau agit sur

Système nerveux autonome | **Système neuroendocrinien** | **Système immunitaire**

Il n'est pas toujours facile de déterminer le ou les systèmes en cause

Le stress modifie les réactions immunitaires, cellulaires, humorales , et les affaiblit

Cœur
HTA

Anorexie
obésité

Diabète
hypoglycémie

Aménorrhée

Troubles
digestifs

Dermatoses

Infections

Cancer

Rhumatisme

SNC
vieillissement

IV. APPROCHE THERAPEUTIQUES EN MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE

1. **Psychothérapeutique**



Écoute psychologique

2. **Techniques de gestion du stress et de relaxation**

3. **Approche psychothérapeutique: TCC, familiale**

4. **Approche pharmacologique** : Antidépresseurs. Benzodiazépines